HÔPITAUX Paris
Saint Joseph Marie Lannelongue

Situation Sanitaire Exceptionnelle - Fondamentaux

Giovanni SILVETTI

- Définitions
- Déclenchement
- Cellule de crise
- Organisation de l'hôpital
- Organisation des services sensibles (Urgences-Réa-Bloc)
- Rôle des services de soins
- Identito-vigilance
- JO 2024
- Rôle des cadres
- Procédure plan blanc

Définitions

Késako ?

- L’Etat dispose de nombreux plans, développés au niveau local ou national en prévision d’accidents de grande ampleur et de catastrophes, destinés à favoriser la qualité de sa réaction et de ses actions.

- Les plans consistent notamment à :
  - Permettre une optimisation de la mobilisation des ressources utiles pour faire face aux situations
  - Faciliter et guider le processus de prise de décision des autorités publiques
  - Proposer des mesures et plans d’action



Législation



- Code de la santé publique – Loi n°2004-806 du 9/08/2004
  - Base légale à l'adoption d'un plan blanc par tous les établissements de santé du territoire.

- Code de la santé publique – version du 27/07/2009 :
  - *"Chaque établissement de santé est doté d'un dispositif de crise dénommé plan blanc, qui lui permet de mobiliser immédiatement les moyens de toute nature dont il dispose en cas d'afflux de patients ou de victimes ou pour faire face à une situation sanitaire exceptionnelle."*

- Plan Blanc encadré par 3 circulaires du ministère de l'Emploi et de la Solidarité :
  - *Circulaire du 2/05/2002 : "L'organisation des soins médicaux en cas d'accident nucléaire ou radiologique"*
  - *Circulaire du 3/05/2002 : "L'organisation du système hospitalier en cas d'afflux de victimes"*
  - *Circulaire du 14/09/2006 : "L'élaboration des plans blancs des établissements de santé et des plans blancs élargis"*

- Le plan blanc peut être déclenché par le directeur ou le responsable de l'établissement de santé public ou privé qui en informe le représentant de l'État dans le département.

- En cas de canicule, pandémie grippale, inondation, etc. l'alerte peut être émise au niveau départemental, régional ou national (Ministère de la Solidarité et de la santé, de la direction générale de la santé, sous-direction de veille et d'anticipation des risques sanitaires).

Késako ?

- SSE : **S**ituations **S**anitaires **E**xceptionnelles
  - Exemple de SSE : Risque climatique, technologique, industriel, naturel, pandémique, terroriste….









Organigramme SSE

National

Ministère de la Santé et des Solidarités

Centre Opérationnel de Réception et de Régulation des Urgences Sanitaires et Sociales (CORRUSS)

Zonal

ARS de zones

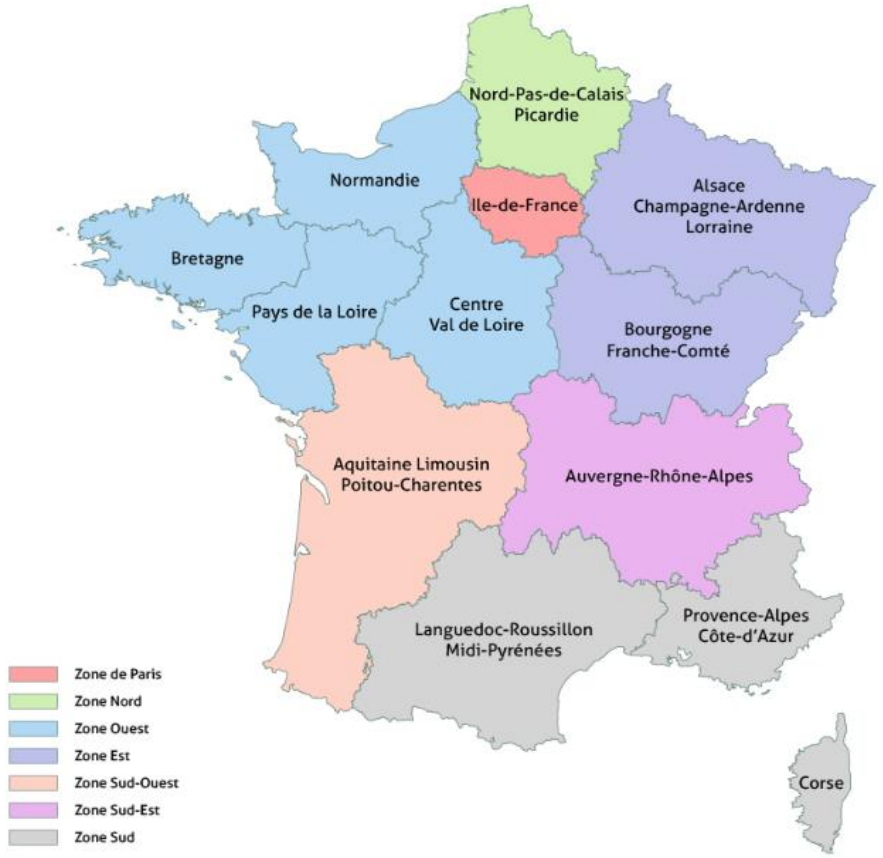
Régional

ARS

Départemental

ESMS | ES | SAMU

7 Zones de défenses France métropolitaine



Plan Blanc, Plan ORSEC, Plan ORSAN : Relations

- **ORSEC / ORSAN = Dispositifs nationaux**
  - ORSEC : **O**rganisation de la **r**éponse de **S**écurité **C**ivile.
  - ORSAN : **O**rganisation de la **R**éponse du système de santé en situations **SAN**itaires exceptionnelles

- **NOVI / AMAVI = Plan d'urgence national**
  - NOVI : **NO**mbreuses **VI**ctimes (plan d'urgence pour secourir un nombre important de victimes dans un même lieu)
  - AMAVI : **A**ccueil **MA**ssif de **VI**ctimes non contaminées (volet du plan ORSAN)

- **Plan Blanc** = Dispositif de crise obligatoire dans chaque établissement de santé

Lien ORSEC – ORSAN

SIVIC



Evènement

NORIA RAMASSAGE

PMA



NORIA EVACUATION

SAMU



HOPITAUX



PLAN ORSEC

SAMU

PLAN ORSAN

Les 5 volets du dispositif ORSAN

AMAVI

Accueil massif de victimes non contaminées d'un événement grave

Catastrophe naturelle
Accident technologique
Attentats avec armes de guerre et/ou engins explosifs

EPI-CLIM

PEC des tensions dans l'offre de soins liées au nombre important de patients suite à une pandémie saisonnière et/ou lors d'un phénomène climatique, voire environnemental important

Canicules
Grand froid

REB

PEC des patients dans le cadre du risque épidémique et biologique connu ou émergent

COVID
EBOLA
H5N1

NRC

PEC des patients dans le cadre d'un risque nucléaire, radiologique ou chimique

Usine AZF (Toulouse)
Tchernobyl / Fukushima

MEDICO-PSY

PEC médico-psychologique des patients victimes d'un événement grave

Accident, Catastrophe, Attentat

Ces 5 volets sont des plans blancs de causes différentes

SI-VIC

- **S**ystème d'**I**nformation pour le suivi des **VIC**times d'attentats et de situations sanitaires exceptionnelles
- SI-VIC est déclenché lors d'évènements et de catastrophes. Il est interconnecté avec SINUS (outil pompier)

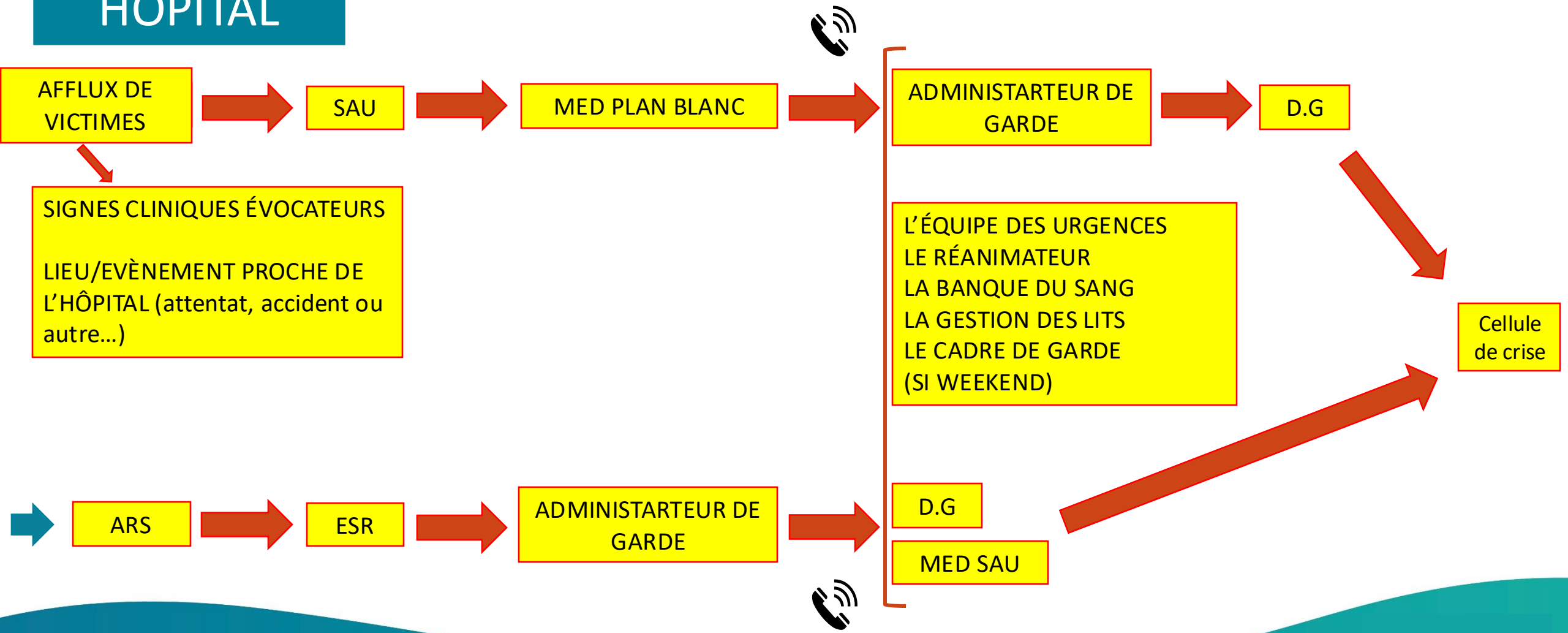
- Il permet de renseigner et de mettre à jour les informations relatives à :
  - L'identité du patient pris en charge ;
  - La prise en charge (hospitalière ou médico-psychologique) du patient ;
  - La personne à contacter, proche du patient.

- Il est accessible via un site web sécurisé pour les établissements de santé, SAMU, ARS, Cellules d'Urgences Médico-Psychologiques)

Déclenchement

Déclenchement

HOPITAL



Cellule de crise

Cellule de crise



- Composition
  - Directeur de l'hôpital (Régis Moreau)
  - Attachée de direction HPSJ (Stéphanie Changarnier)
  - Attaché de direction HML (Alex Moore)
  - Administrateur de garde
  - Cadre de garde/nuit
  - Urgences (chef de service/adjoint)
  - Bloc opératoire
  - Directrice de soins
  - Président de la Commission Médicale d'Etablissement
  - Qualité - gestion des risques (Marie-Hélène Painchaud/ Davina Sumbal)
  - …
- Vision panoramique du pré-hospitalier, du terrain, des autres hôpitaux
- En lien avec l'ARS

Rôle de la cellule de crise

- L’organisation de la prise en charge médicale
  - Etats des lits
  - Rappel de personnel
  - Déprogrammation de patients convoqués…
- La sûreté/sécurité
- Le suivi des victimes
- La prise en charge des familles
- Les fonctions support et la communication

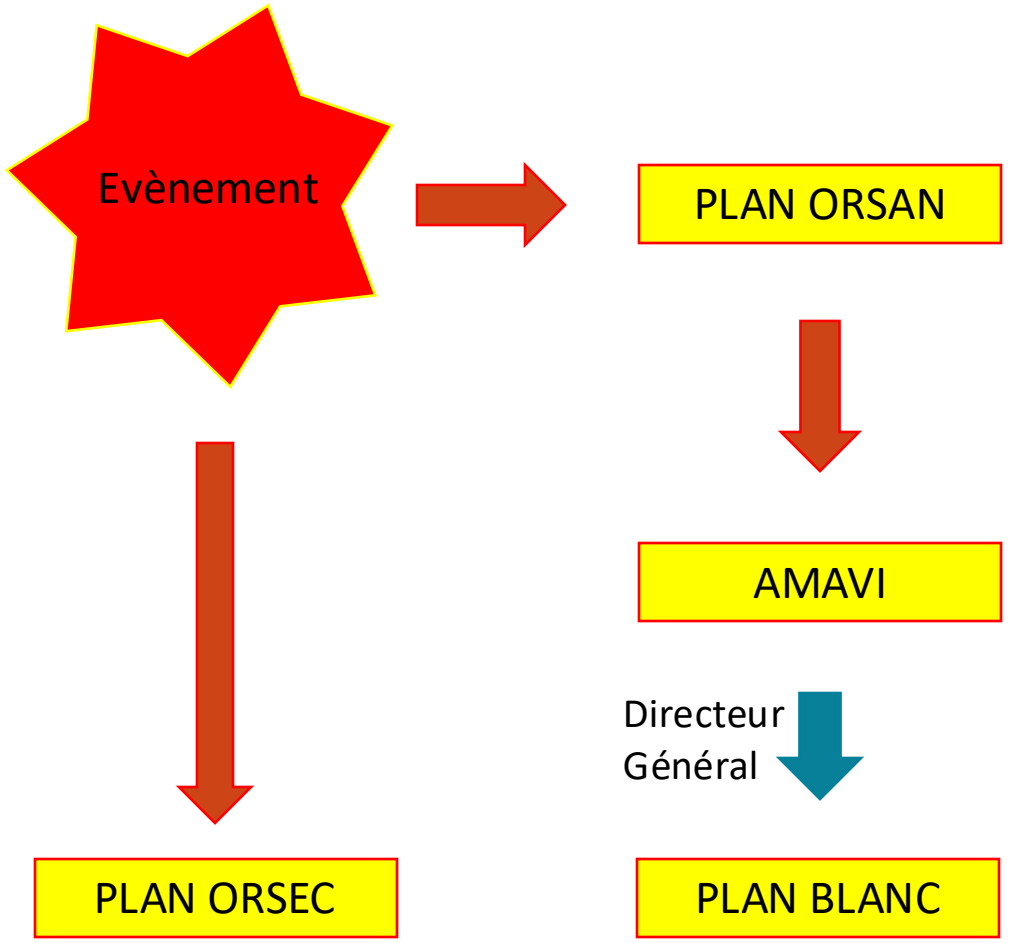


Organisation de l'hôpital

Organisation hôpital

- Une seule entrée fonctionnelle au 189 pour les patients
- Entrée du personnel au 185 (filtrage par agent de sécurité). Contrôle des identités = badge obligatoire
- Blocage entrées/sorties de l'hôpital = décision cellule de crise
  - Si risque NRBC, **pas de sorties** = éviter de contaminer les extérieurs
  - Les entrées peuvent être bloquées en fonction de la nature de l'attentat
- En fonction de la typologie et du nombre de victimes = décision du directeur de fermer ou non différents secteurs (bloc, consultations…)
- Levée du plan blanc = décision du directeur de l'établissement en accord avec les autorités

Organisation des services sensibles (Urgences-Réa-Bloc)



PLAN BLANC

HOPITAL

- SAU
  - Fermeture SAU : 1 entrée unique
  - Répartition des effectifs par zones
  - Transfert des patients dans les services
  - Accueil des victimes
  - Identito-vigilance
- REA
  - Sortie de 2 patients vers USIC/USINV
  - Réanimateur en SSPI
- SSPI BLOC
  - Arrêt de certains blocs
  - Sortie/Transfert patients SSPI vers USIC/USINV
  - Accueil victime UA du SAU
- SERVICES
  - Accueil des patients présents aux SAU avant déclenchement Plan Blanc
  - Ne pas aller aux urgences sans sollicitation

Organisation et affectation des ressources au SAU avant l'arrivée des victimes









Zone « UA » :
(Urgences Absolues)
1 sénior + 1 IDE

Zone « IMP » (Impliqués) :
1 sénior + 1 IDE
+ 1 interne
Zone « valides hors
Plan Blanc »

SAUV

Zone
« couchés hors
Plan Blanc »

Zone « UR » :
(Urgences Relatives)
2 séniors + 2 IDE

IAO
1&2

MAO

Salle d'attente pour
les patients Impliqués
« IMP » et patients
« Valides hors
Plan Blanc »

AMA

Attente transfert

Zone Transitoire :
1 interne + 1 IDE

ACCUEIL
ADMINISTRATIF
Agent administratif +
ASH «renfort administratif»

Zone de tri :
Sénior +
AS identitovigilance

SAU GHPSJ - Zoning plan blanc

Exemples de fiches réflexes

Plan blanc – Fiche réflexe

06/12/2023

Missions de l'« IDE Plan Blanc » Tel 7158

AVANT L'ARRIVEE DES VICTIMES ET DES RENFORTS

☐ Rassembler tout le monde dans le poste de soins (+ 1 AS LP : 8045/6159)
☐ Prévenir l'accueil au 3458 ou 5093
☐ Appeler le 5454 et demander l'affectation immédiate de deux brancardiers aux urgences
➔ Remettre à chaque brancardier sa fiche reflexe

☐ Ouvrir la mallette « Plan Blanc » + Mallette « Chasubles »
☐ Afficher le plan des urgences
☐ Désigner les rôles et donner les fiches réflexes comme suit :
1 – Désigner 1 AS « Plan Blanc »
2 – Désigner 2 ASH « renfort-administratif »
3 – Désigner 1 AS « Identitovigilance » + Ouvrir malle « AS IDENTITOVIGILANCE » et prendre les pochettes « Dossier patient », à mettre à l'accueil
4 – Désigner 1 IDE UA (SAUV)
5 – Désigner 1 IDE UR (Zone 2A)
6 – Désigner 1 IDE Impliqué (Zone 1)
7 – Désigner 1 IDE Zone transitoire (Zone 2B)
8 – Désigner 1 AS par zone (UA + UR + Impliquée)
9 – Désigner 1 ou 2 IDE IOA
10 – Désigner 1 AS LP
11 – Désigner 2 Brancardier
12 – Désigner 1 IPA
13 – Désigner 1 IDE psy
14 – Appel secrétaire (77.58) et AMA (39.49 / 74.52)



☐ Alerter les cadres du service :
Mélanie Luce DECT : 7657 / Portable : 06 50 60 88 95
Ericka MARTIAL DECT : 80.21 / Portable : 06 04 96 79 74
Cadre de nuit 67.12

☐ Transmettre ses patients en cours de prise en charge à l'IDE zone transitoire
☐ Contrôler le port de la chasuble + pochette avec matériel par tous selon la zone de soins Plan blanc :
Impliqués : vert ; Urgences Relatives : orange ; Urgences Absolues : rouge
Les médecins et internes doivent porter une chasuble « Médecin »
☐ Contrôler la présence du matériel dans chaque zone (registre, paper board) et la présence des rolls
☐ Appeler en renfort les IDE selon les effectifs prévus, répartir les effectifs paramédicaux + DECT selon le tableau ci-joint et l'écrire sur le plan
☐ Afficher la feuille d'émargement des renforts à l'accueil administratif du SAU, avec l'heure d'arrivée
☐ Dès l'arrivée d'un encadrant paramédical du SAU, lui faire un état des lieux et se positionne en zone 2 pour prendre en charge les patients hors Plan Blanc.

1URG-INFO-061

27-07-2021

Missions de l'IDE Zone Transitoire (DECT : 83.29)

AVANT L'ARRIVEE DES VICTIMES ET DES RENFORTS

☐ Lire sa fiche réflexe
☐ Se positionner dans sa zone
☐ Prendre son DECT : 8329

☐ Prendre les transmissions des patients déjà aux urgences
☐ Se positionner dans sa zone : E, box 17, 18, 19, couloir
☐ Organiser la zone :
Zone E et couloir pour les patients à hospitaliser
Box 17-18-19 pour les patients moribonds
☐ Tableau velleda pour décompte des victimes
☐ Registre de décompte des patients présents
☐ Faire monter dans les étages les patients transmis hors plan blanc (en lien avec le gestionnaire de lits)
☐ Prise en charge des patients hors plan blanc (après transfert des autres)

ORGANISATION DU TRANSFERT DES PATIENTS VERS LES ETAGES

- **Envoyer les patients 2 par 2, en respectant l'ordre suivant :**
1- Rhumatologie/Médecine interne (P14 N1) – DECT : 68.25/ 38.60(R)
2- Urologie (NDBS N2) – DECT : 38.34
3- Médecine vasculaire (St Vincent N1) – DECT : 37.62
4- ORL / Proctologie / CMF (P5 N1) – DECT : 34.34
5- Pneumologie (P14 N3) – DECT : 33.92
6- Gynécologie / plastique (NDBS N4) – DECT : 81.40
7- Chirurgie vasculaire (P6 N1) – DECT : 74.94
8- Chirurgie digestive (P5 N2) – DECT : 76.88
9- Médecine interne (P14 N4) – DECT : 71.30
10- Neurologie (P4 N3) – DECT :
11- Orthopédie (P5 N3) – DECT :
12- Médecine vasculaire (Saint Vincent N2) – DECT : 72.73
13- Oncologie (P14 N5) – DECT : 83.41
14- Gastro-entérologie (P1 N2) – DECT : 31.88
15- Diabétologie (P2 N2) – DECT : 39.58
16- Orthopédie (P1 N3) – DECT :
17- Cardiologie (P2 N2) – DECT : 34.04
18- Neurologie (P6 N3) – DECT :
19- Médecine vasculaire (Saint Vincent N3) – DECT : 32.
20- Suites de couche (NDBS N5) – DECT : 81.50
21- Suites de couche (NDBS N6) – DECT : 81.60

A L'ARRIVEE DES VICTIMES

☐ PEC des patients moribonds

[Ne pas supprim

Plan blanc – Fiche réflexe

27/10/2023

Missions de l'AS Identitovigilance

AVANT L'ARRIVEE DES VICTIMES

☐ Lire sa fiche réflexe
☐ Ouvrir la malette AS IDENTITOVIGILANCE et récupérer le carton contenant les pochettes « Dossier patient »



☐ SE POSITIONNER DANS LE SAS POMPIER
☐ Déposer les pochettes « Dossier patient » sur le bord de l'accueil côté entrée secours

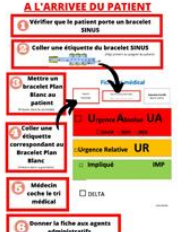


L'AS IDENTITOVIGILANCE NE DOIT JAMAIS QUITTER LE SAS POMPIERS

A L'ARRIVEE DES RENFORTS

☐ Vérifier si le patient porte un bracelet SINUS ()
NE JAMAIS RETIRER LE BRACELET SINUS, JUSQU'A LA SORTIE DU PATIENT
☐ Prendre une pochette « Dossier patient »
☐ Prendre une étiquette du bracelet SINUS et la coller sur la fiche Tri médical (2)
☐ Prendre le bracelet « Identité Plan Blanc » et le mettre au poignet du patient. (3)
☐ Récupérer la fiche « Tri médical » rempli par le médecin [illegible] l'agent d'accueil (5 et 6)





Missions de l'ASH « Renfort Administratif » Tel 7316

AVANT L'ARRIVEE DES VICTIMES ET DES RENFORTS

☐ Lire sa fiche réflexe
☐ Prendre son DECT : 73.16
☐ Descendre au -1 avec AS « Plan Blanc » et les externes
Niveau -1 sous les lits d'urgences Digicode : C1267
☐ Monter les rolls en empruntant l'ascenseur des urgences
En cas de panne de l'ascenseur du SAU : emprunter les ascenseurs de la galerie St-Jean, porte 2 pour monter les rolls (flèches bleues sur le schéma ci-dessous).
☐ Avec l'AS « Plan Blanc » et les externes, installer le matériel dans le SAU (voir affichage sur les rolls et paperboards)
☐ De jour, 4 renforts administratif (secrétaire, ASH + AMA)

A L'ARRIVEE DES VICTIMES

Dès l'arrivée des premiers patients dans la zone de soins :

☐ Se rendre dans l'une des zones Impliquée, UR, UA.
☐ Prendre dans la pochette « Dossier Patient » présent avec le patient, la fiche « Recueil de données administratives ».



LAISSER LA POCHETTE AVEC LES AUTRES DOCUMENTS AU PATIENT.

☐ Si le patient à un bracelet SINUS : prendre une étiquette du bracelet et la coller sur la fiche.
☐ Remplir la fiche avec le plus d'informations possible :
➤ Si le patient est conscient et orienté : Faire épeler les noms, prénom et date de naissance (l'ensemble des éléments de chaque fiche doit être renseigné, sauf si non adapté ou incapacité totale de les obtenir)
➤ S'il n'est pas conscient, fouiller dans les affaires pour trouver une identité *(CNI, permis de conduire, carte vitale, Passport, …)*
☐ Transmettre la fiche remplie et les pièces d'identité à l'accueil administratif
☐ Récupérer les nouvelles étiquettes avec l'identité contrôlée et les papiers d'identité du patient.
☐ Restituer les papiers d'identité au patient
☐ Mettre un bracelet au patient avec les nouvelles étiquettes.

Attention il ne faut pas retirer les autres bracelets

27-07-2021

Missions de l'Externe

AVANT L'ARRIVEE DES VICTIMES ET DES RENFORTS

☐ Lire sa fiche réflexe
☐ Se mettre avec l'AS « Plan Blanc » et l'ASH « renfort administratif ».
☐ Descendre au -1 avec AS « Plan Blanc »
Niveau -1 sous les lits d'urgences Digicode : C1267
☐ Monter les rolls en empruntant l'ascenseur des urgences
En cas de panne de l'ascenseur du SAU : emprunter les ascenseurs de la galerie St-Jean, porte 2 pour monter les rolls (flèches bleues sur le schéma ci-dessous).



☐ Avec l'AS « Plan Blanc » et les externes, installer le matériel dans le SAU :
☐ Installer les rolls Plan Blanc dans le couloir contre le mur de la zone F
☐ Déposer les boites de garrots (à l'étage supérieur du roll n°3) sur le chariot de soins de la SAUV.
☐ Installer les paper-boards : 1 en zone de tri, 1 devant le box 1, 1 dans la zone UR, 1 en zone UA et 1 en zone transitoire.
☐ Installer le roll signalétique à côté de l'entrée du poste de soins



Lorsque l'installation est terminée :
☐ Se mettre à disposition dans une zone de soins (impliquée, UR, UA).

[Ne pas supprimer ce texte]

Plan blanc – Fiche réflexe

27-07-2021

Missions de l'Infirmière de psychiatrie (7677)

AVANT L'ARRIVEE DES VICTIMES

☐ Lire sa fiche réflexe
☐ Se positionner dans la salle d'attente des patients valides devant l'accueil administratif

A L'ARRIVEE DES VICTIMES

☐ Prendre contact avec les victimes impliquées dans la catastrophe, les rassurer et évaluer les patients susceptibles d'être isolés

☐ Recueil d'informations administratives (pour permettre à l'agent administratif de réaliser l'inscription dans DxCare)

☐ Transmet les éléments à l'agent administratif

☐ Si urgence psychiatrique / contention :
Isoler le patient dans un box avec l'aide de l'IDE de la zone « impliqués » et appeler le médecin de la zone ou le psychiatre pour prescription médicale

Missions brancardier
Plan blanc au SAU

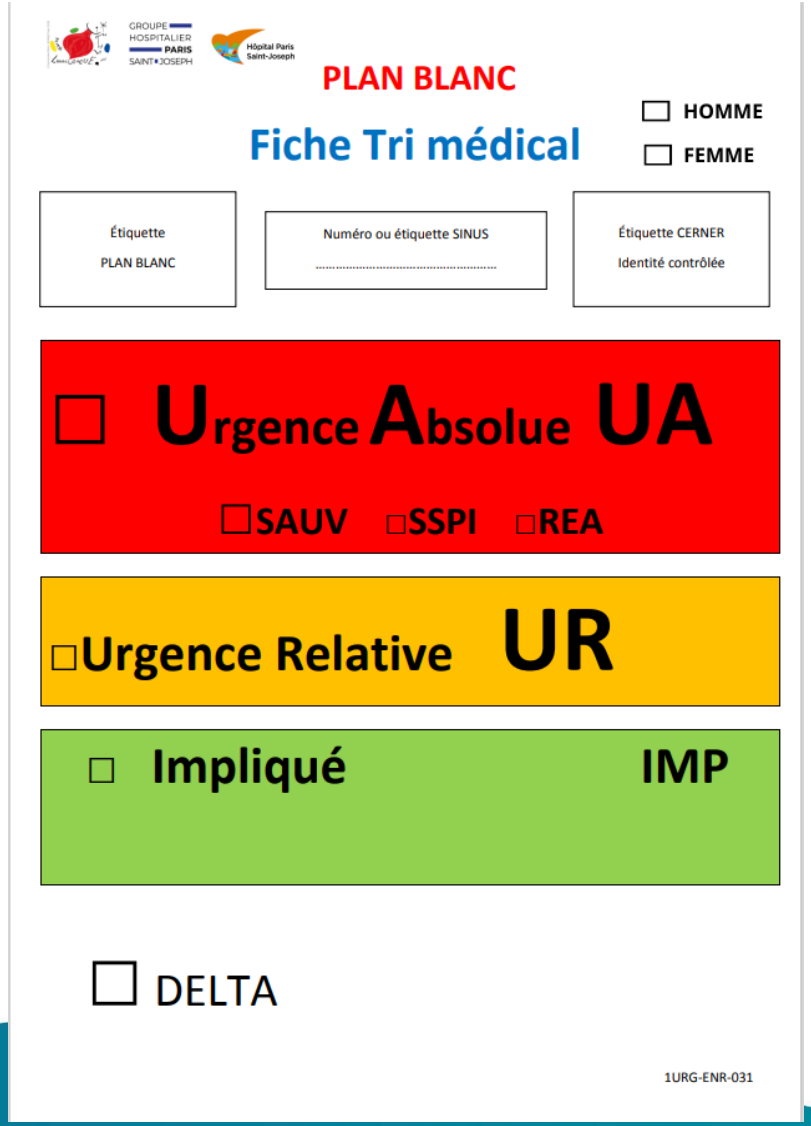
AVANT L'ARRIVÉE DES VICTIMES

☐ Lire sa fiche réflexe
☐ Aller dans le SAS Pompier
☐ Compter le nombre de brancards et de fauteuils
■ Il DOIT Y AVOIR DANS LE SAS POMPIER
➔ 20 Brancards minimum
➔ 10 Fauteuils minimum
Si pas assez de brancards et/ou fauteuil :
☐ Aller chercher des brancards et des fauteuils
☐ Positionner les brancards et les fauteuils dans le SAS Pompier
Si vous avez fini avant l'arrivée des victimes, aidez les équipes à déplacer les patients présents dans les urgences vers la zone transitoire.

A L'ARRIVÉE DES VICTIMES

☐ Se positionner dans le SAS pompier avec l'AS identitovigilance et le médecin trieur.
☐ Installez les patients dans les différentes zones en fonction du tri du binôme de l'accueil
- **Impliqués (IMP)** vers l'accueil des urgences pour inscription (traverser l'accueil administratif pour rejoindre la salle d'attente valide où ils s'inscrivent)
- **Urgences Relatives (UR)** : dirigés et accueillis directement en zone de prise en charge
- **Urgences Absolues (UA)** : vers la réanimation ou la SSPI selon consignes du senior
- **Urgences Absolues (UA)** non régulés : vers la SAUV
- **Moribonds** : en zone transitoire

Tri SAU



PLAN BLANC

Fiche Tri médical

☐ HOMME
☐ FEMME

Étiquette PLAN BLANC	Numéro ou étiquette SINUS	Étiquette CERNER Identité contrôlée

☐ Urgence Absolue UA

☐SAUV ☐SSPI ☐REA

☐Urgence Relative UR

☐ Impliqué IMP

☐ DELTA

1URG-ENR-031

UA (urgence absolue)	• Victime en danger de mort immédiate • Geste chirurgical de sauvetage • Instabilité, décompensation d'une fonction vitale • Lésion avec impact fonctionnel évident (visage, œil, main)
UR (Urgence relative)	• Pas d'engagement du pronostic vital à court terme • Traumatisme susceptible de s'aggraver (thorax, abdomen, crâne) • Traitement chirurgical pouvant être différé • Blessures légères
IMP (Impliqué)	• Pas de prise en charge organique urgente • Nécessité d'écoute ou d'information
UD ou DELTA (Urgence dépassée)	• Lésions gravissimes avec peu de chance de survie • Patient décédé

Rôle des services de soins

PATIENTS DES URGENCES

Appel des infirmiers dans les services pour accueillir 2 patients en 30 minutes

Appel pour une capacité potentielle de lits supplémentaires

- Fait par la gestion des lits - les cadres - les IDE
- En fonction de la temporalité : Jour – Nuit – Weekend



Identito-vigilance

Gestion des effets personnels

- Affaires dans un sac
- Pas d'inventaire fait aux urgences
- A faire dans les services

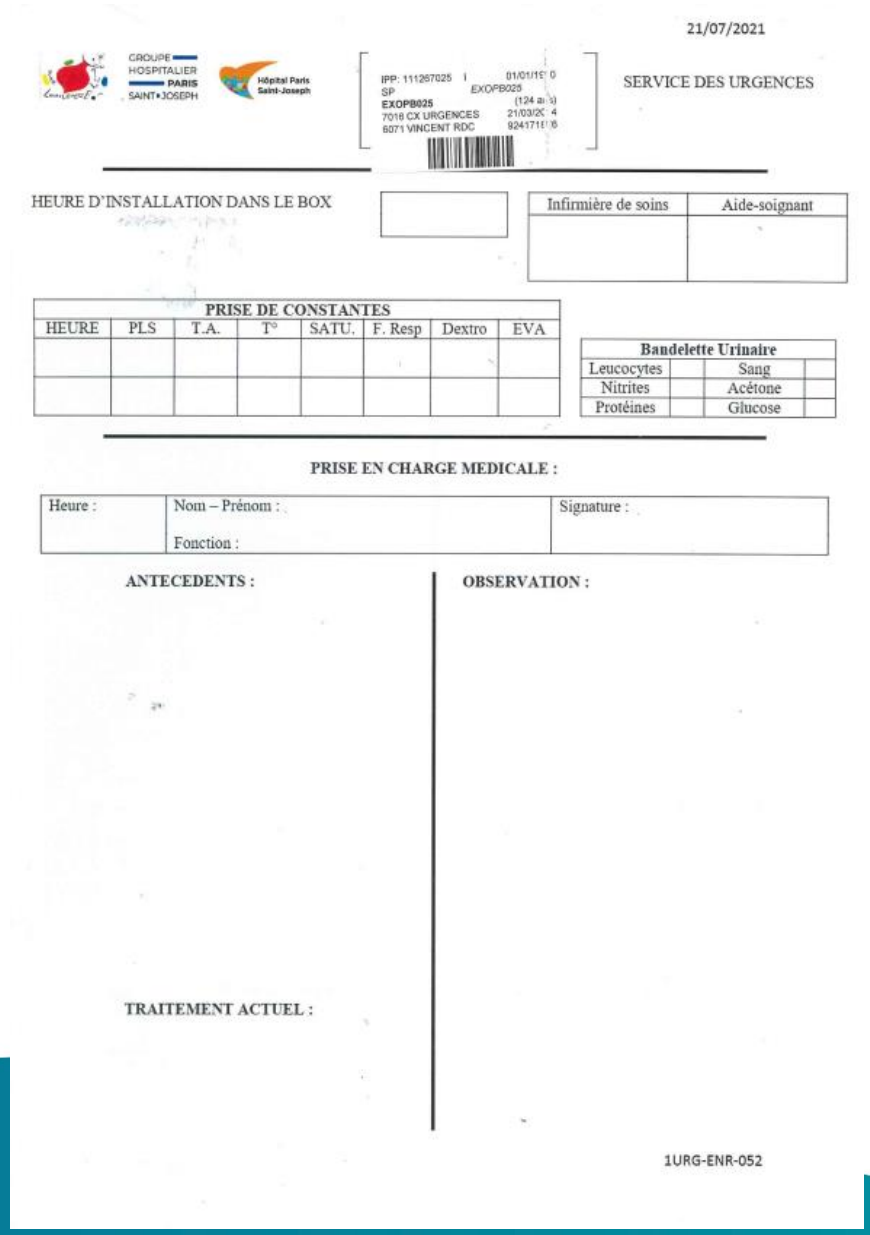
PATIENTS DE REANIMATION ET DU BLOC

Appel des infirmiers dans les services d'USIC ou USINV pour accueillir 2 patients en 30 minutes

Appel pour une capacité potentielle de lits supplémentaires

- Fait par la gestion des lits - les cadres - les IDE
- En fonction de la temporalité : Jour – Nuit – Weekend

Dossier de procédure dégradée



21/07/2021

GROUPE HOSPITALIER PARIS SAINT-JOSEPH — Hôpital Paris Saint-Joseph

IPP: 111267025 — SP — EXOPB025 — EXOPB025 — 7016 CX URGENCES — 6071 VINCENT RDC

SERVICE DES URGENCES

HEURE D'INSTALLATION DANS LE BOX

Infirmière de soins	Aide-soignant

PRISE DE CONSTANTES

HEURE	PLS	T.A.	T°	SATU.	F. Resp	Dextro	EVA

Bandelette Urinaire			
Leucocytes		Sang	
Nitrites		Acétone	
Protéines		Glucose	

PRISE EN CHARGE MEDICALE :

Heure :	Nom – Prénom : Fonction :	Signature :

ANTECEDENTS :

OBSERVATION :

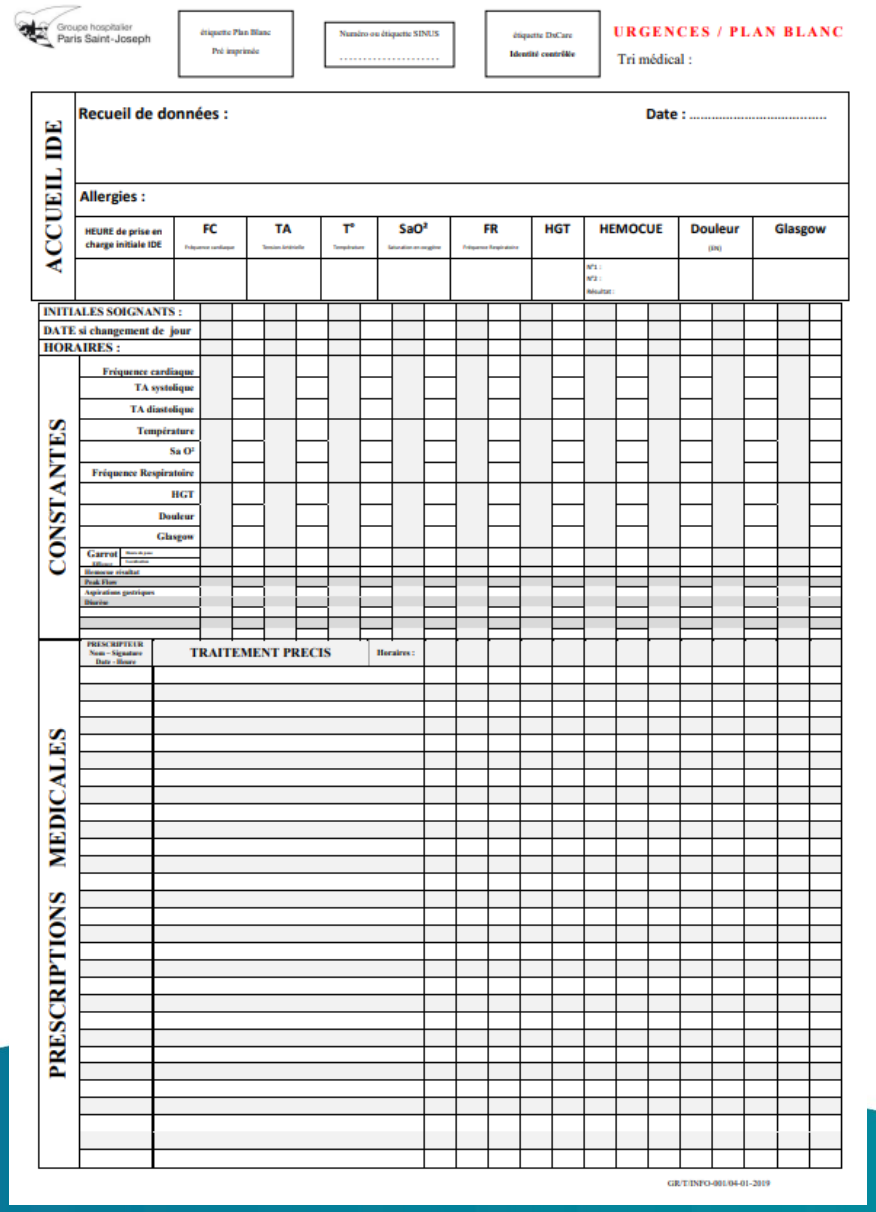
TRAITEMENT ACTUEL :

1URG-ENR-052

- Observation médicale

Ennov : 1URG-ENR-052

Dossier de procédure dégradée



Groupe hospitalier Paris Saint-Joseph

étiquette Plan Blanc
Pré imprimée

Numéro ou étiquette SINUS

étiquette DxCare
Identité contrôlée

URGENCES / PLAN BLANC

Tri médical :

ACCUEIL IDE

Recueil de données : Date : .....

Allergies :

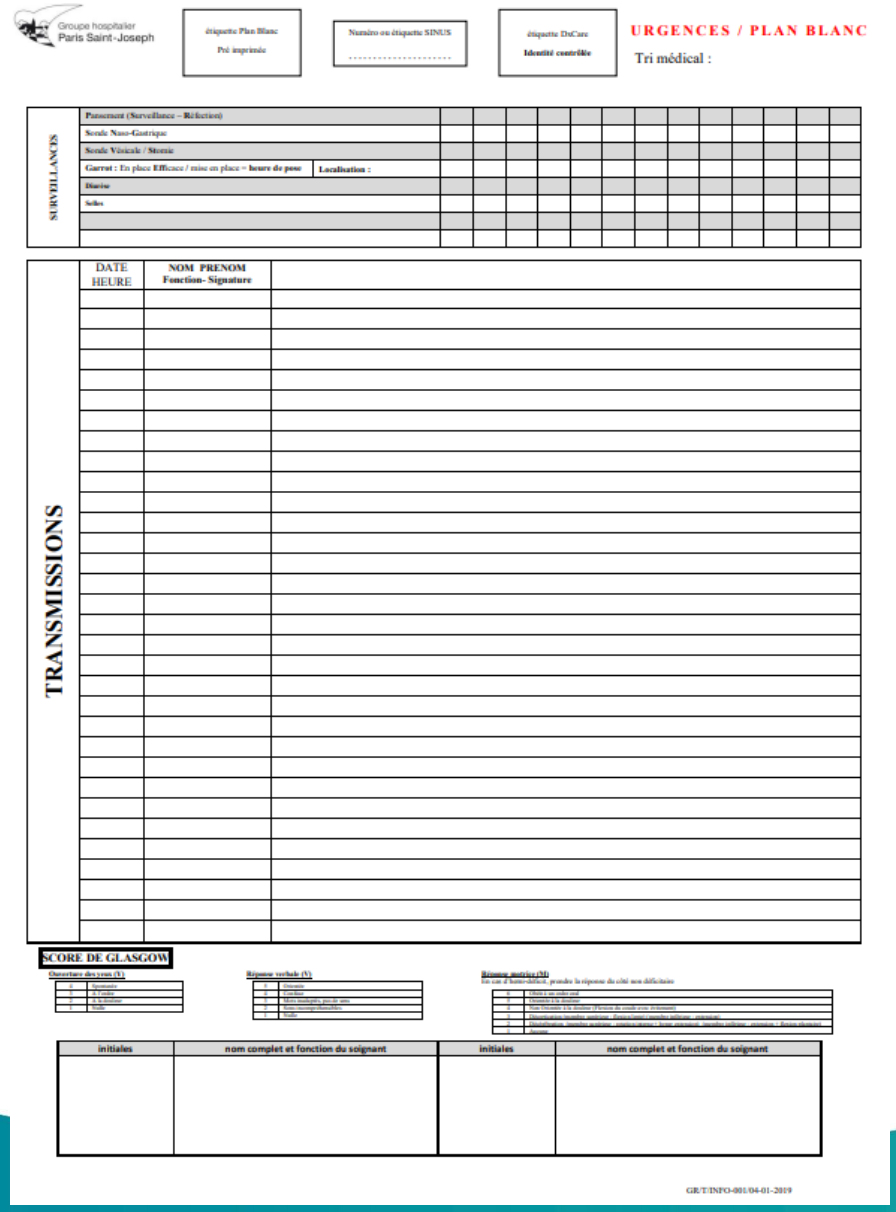
HEURE de prise en charge initiale IDE	FC	TA	T°	SaO²	FR	HGT	HEMOCUE	Douleur	Glasgow
							N°1 : N°2 : Résultat :		

INITIALES SOIGNANTS :																								
DATE si changement de jour																								
HORAIRES :																								
CONSTANTES	Fréquence cardiaque																							
	TA systolique																							
	TA diastolique																							
	Température																							
	Sa O²																							
	Fréquence Respiratoire																							
	HGT																							
	Douleur																							
	Glasgow																							
	Garrot (Heure de pose / Localisation)																							
	Alléssi																							
	Hemocue résultat																							
	Peak Flow																							
	Aspirations gastriques																							
	Diurèse																							

PRESCRIPTIONS MEDICALES

PRESCRIPTEUR Nom - Signature Date - Heure	TRAITEMENT PRECIS	Horaires :

GR/T/INFO-001/04-01-2019



Groupe hospitalier Paris Saint-Joseph

étiquette Plan Blanc
Pré imprimée

Numéro ou étiquette SINUS

étiquette DxCare
Identité contrôlée

URGENCES / PLAN BLANC

Tri médical :

SURVEILLANCES

Pansement (Surveillance – Réfection)																								
Sonde Naso-Gastrique																								
Sonde Vésicale / Stomie																								
Garrot : En place Efficace / mise en place = heure de pose	Localisation :																							
Diurèse																								
Selles																								

TRANSMISSIONS

DATE HEURE	NOM PRENOM Fonction- Signature	

SCORE DE GLASGOW

Ouverture des yeux (V)

4	Spontanée
3	A l'ordre
2	A la douleur
1	Nulle

Réponse verbale (V)

5	Orientée
4	Confuse
3	Mots inadaptés, pas de sens
2	Sons incompréhensibles
1	Nulle

Réponse motrice (M)
En cas d'hémi-déficit, prendre la réponse du côté non déficitaire

6	Obéit à un ordre oral
5	Localise la douleur
4	Non Orientée à la douleur (Flexion du coude avec évitement)
3	Décortication (membre supérieur : flexion/contact membre inférieur : extension)
2	Décérébration (membre supérieur : extension/adduction ; membre inférieur : extension ; flexion plantaire)
1	Aucune

initiales	nom complet et fonction du soignant	initiales	nom complet et fonction du soignant

GR/T/INFO-001/04-01-2019

- Feuille de surveillance

Ennov : 1URG-ENR-010

Identito-vigilance

Bracelet Sinus



- Mis en place par les secours en pré-hospitalier
- Système d'information numérique standardisé (en lien avec SI-VIC)
- Le système SINUS permet le recensement et le suivi des victimes

- Il permet d'établir rapidement un bilan chiffré proche de la réalité et de classer ces données par spécificité : tranches d'âges, sexe, nationalité, domicile, lieu d'hospitalisation, etc.

- Le format du numéro SINUS se compose de 21 caractères :
- Exemple : FR240NOVI0000TR500001

Bracelet Plan blanc

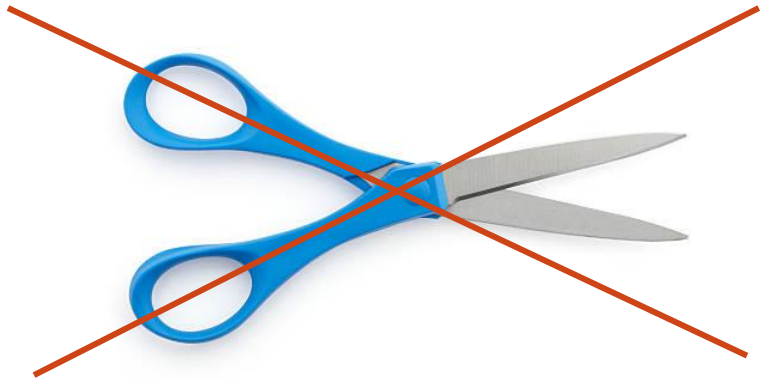
- Mis en place par AS identitovigilance dès l’accueil aux urgences
- Identité provisoire



Bracelet Identité vérifiée

- Mis en place dans un second temps, après avoir vérifié et/ou identifié la victime



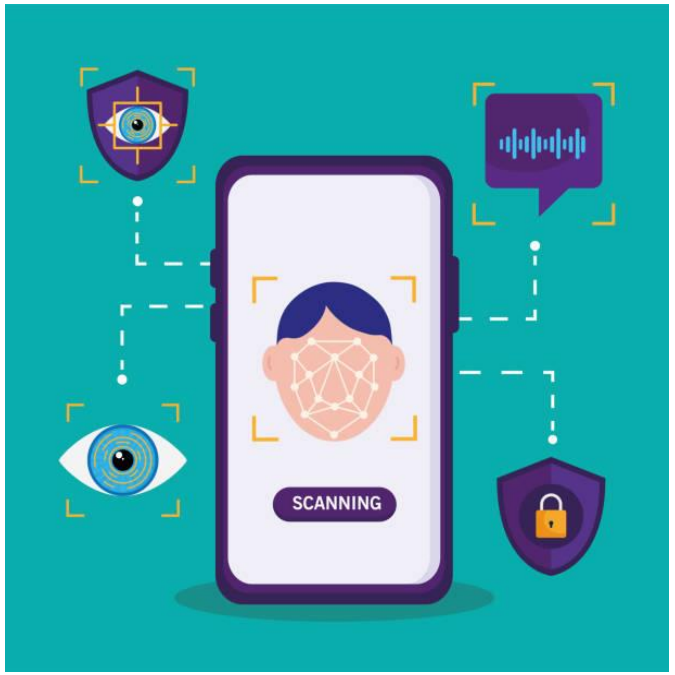


NE COUPER AUCUN BRACELET





IDENTITO-VIGILANCE +++



Fiche de recueil de données administratives

Groupe hospitalier Paris Saint-Joseph

PLAN BLANC

Recueil de données administratives

Étiquette CERNER Pré imprimée	Numéro ou étiquette SINUS	Étiquette CERNER Identité contrôlée

NOM DE NAISSANCE : .....

NOM USUEL : .....

PRENOM : .....

Sexe : .....

Date de Naissance : .....

Si mineur, NOM DES PARENTS : .....

En cas de recueil impossible voir au verso

Personne à prévenir : .....

☛ Téléphone : .....

Accompagnant présent ☐ .....

☐ **PIECE D'IDENTITE** ☐ **CARTE VITALE**

- ☐ INCONSCIENT(E)
- ☐ PARTI(E) AU BLOC OPERATOIRE
- ☐ PARTI(E) EN REANIMATION
- ☐ PARTI(E) (indiquer la destination si connue) :
- ☐ TRANSFERT (indiquer le service) :
- ☐ DELTA

ECRIRE TRES LISIBLEMENT SVP

Urgences/I/ENR-056-11/04-01-2019

En cas de recueil de données impossible, description des signes distinctifs

Type :

☐ caucasien	☐ asiatique
☐ méditerranéen	☐ indo-pakistanais
☐ africain	☐ latino-américain
☐ moyen-oriental	☐ autre :

Cheveux : Couleur : ☐longs ☐courts ☐rasés

Yeux : Couleur :

Porteur de lunettes : ☐ oui ☐ non Porteur de verre de contact : ☐ oui ☐ non

Poids approximatif :

Taille approximative :

Pour vous aider à évaluer :



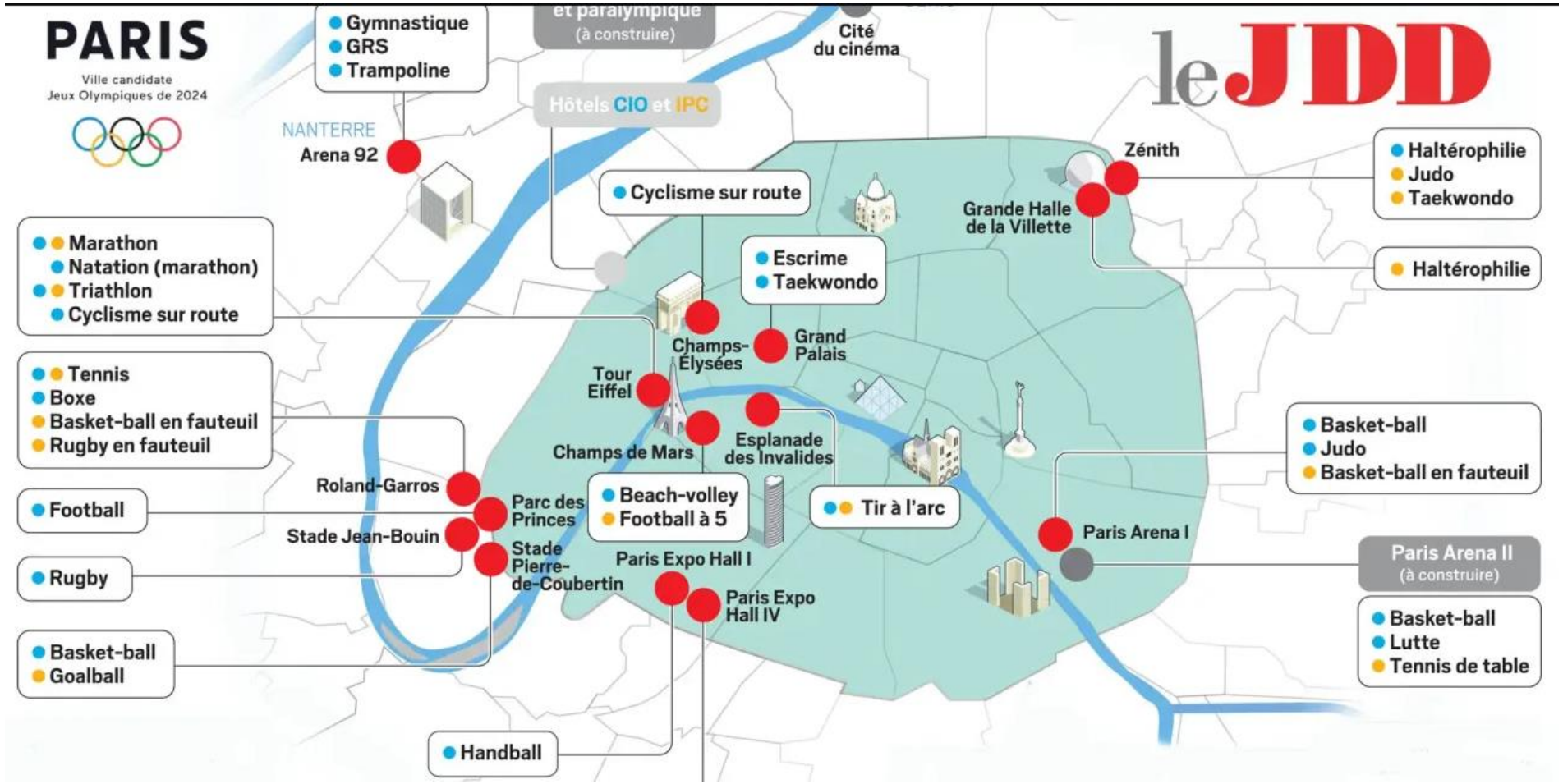
Signes particuliers distinctifs : (cicatrices, tatouages, piercing ...)

ECRIRE TRES LISIBLEMENT SVP

Urgences/I/ENR-056-04-01-2019

Concrètement JO euro 2024

Quel impact pour nous ?



Quel impact pour nous ?

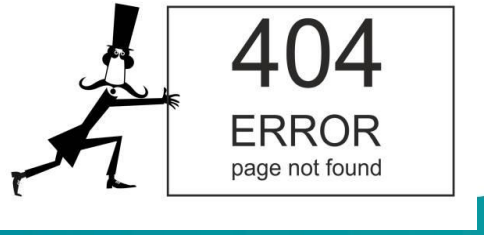


- **Plusieurs sites à proximités :**
  - Parc des expositions de Versailles
  - Champs de mars
  - Tour Eiffel
  - Esplanade des invalides
- Centre de 1er secours sur chaque site
- Hôpitaux de référence : AP-HP (Saint-Joseph n’est pas un Hôpital de référence)
  - Conséquences : Environ 15,3 millions de visiteurs attendus (potentiellement des patients internationaux).

Quel impact pour nous ?



- **Les risques :**
  - Sécurité :
    - Attentats (AMAVI et ou NRC)
    - Cyber attaques
  - Pandémique :
    - Propagation virale ou bactérienne
    - Grippe, Covid, Dengue, Paludisme, Rougeole
    - BHRe / Candida Auris
    - IST
  - Climatique :
    - Les experts annoncent une canicule
  - *Compréhension : Nous allons devoir parler anglais ! Speak in english please*



Rôle des cadres

Rôle cadre en semaine

- Gestion des lits
  - Accueillir 2 patients en 30 minutes.
    - Surbookés ou sur des sorties de patients (en lien avec le médecin de salle)
  - Libérer d'autres lits si possible
- Relais entre les patients et les accompagnants aux urgences

Rôle cadre de garde

Fiche réflexe : Cadres de garde ou de nuit

1. Se rendre en salle de cellule de crise (salle de réunion de la DG ; code porte permettant d'accéder aux escaliers 7315 A) et identifier le type de crise avec l'administrateur de garde.

2. En période de vacances scolaires, demander au cadre d'astreinte de se déplacer

3. Appeler le brancardage au 5454 et affecter :
   - 2 brancardiers au SAU (en cas d'afflux de victimes)
   - 1 brancardier en réanimation ou salle de réveil pour y libérer des lits
   - 1 brancardier en imagerie pour vider ce secteur

   Une fois leur tâche accomplie, réaffecter ces deux brancardiers aux secteurs le nécessitant.
   - Prévenir Olivier Richard : 06 81 38 27 23

4. Etablir la situation des lits sur le **site HPSJ** (n° HML à contacter sur demande du directeur)

Services	Numéro de téléphone	Capacité d'accueil
Hôpital		Le nombre de lits disponibles sur l'hôpital ➔ utiliser le dernier taux d'occupation
Urgences générales	Sénior des urgences **01 44 12 77 90**	o Situation de tension o Capacité d'accueil en : - Urgence absolue (UA) - Urgence relative (UR)
Réanimation	- **HPSJ** : o Réanimateur de garde : **01 44 12 69 91** - **HML** : o Réanimateur **adulte** de garde : **01 40 94 85 83** o Réanimateur **congénital** de garde : **01 40 94 85 96**	Nombre de lits disponibles
Bloc opératoire	- **HPSJ** : o Régulation du bloc : **01 44 12 76 18** o Anesthésiste de garde : **01 44 12 71 01** - **HML :** o Directrice du bloc **01 40 94 85 26** o Cadre de garde qui contactera les équipes de garde : **01 40 94 88 12** o Anesthésiste de garde : **01 40 94 87 44**	Nombre de salles opératoires disponibles dans 1h puis dans les 2h et 3h Nombre de lits disponibles en salle deréveil / UPOP

Puis en fonction de la situation

Services	Numéro de téléphone	Capacité d'accueil
Plateau technique interventionnel	**HPSJ** : Cadre **01 44 12 76 47** Ou voir liste d'astreinte sur le R. **HML** : cadre au **01 40 94 86 15**	Nombre de salles disponibles dans 1h
USIC	**HPSJ** : Cadre au **01 44 12 69 41** Ou cardiologue de garde au **01 44 12 77 91** **HML** : cadre au **01 40 94 85 46**	Nombre de lits disponibles
USINV	Infirmière référente au **01 44 12 37 49** Ou neurologue de garde au **01 44 12 79 92**	Nombre de lits disponibles
Salle de naissance	Poste de soins **01 44 12 81 70**	- Nombre d'accouchements en cours - Nombre de patientes en attente d'accouchement - Nombre d'urgence obstétricale en cours

- Fiche réflexe (à retrouver sur Ennov', référence : 1CRISES-INFO-001)

5. Demander à tous les services le maintien des effectifs médicaux et paramédicaux
   - ➪ Appeler en premier :
   - dépôt de sang : 01 44 12 34 56
   - radiologue de garde : 01 44 12 78 51
   - biologiste de garde : jour : 01 44 12 34 54 / nuit : 01 44 12 77 31
   - pharmacien de garde : 01 44 12 77 05
   - pédiatre de garde : 6708
   - chambre mortuaire : 01 44 12 68 02 demander la capacité d'accueil
   - ➪ Selon la situation, appeler les médecins et chirurgiens d'astreinte (*voir annexe 4 page 51 : n° gardes,astreintes)*

6. Demander au sénior des urgences (01 44 12 77 90) si des patients sont à transférer des urgences vers les unités d'hospitalisation.

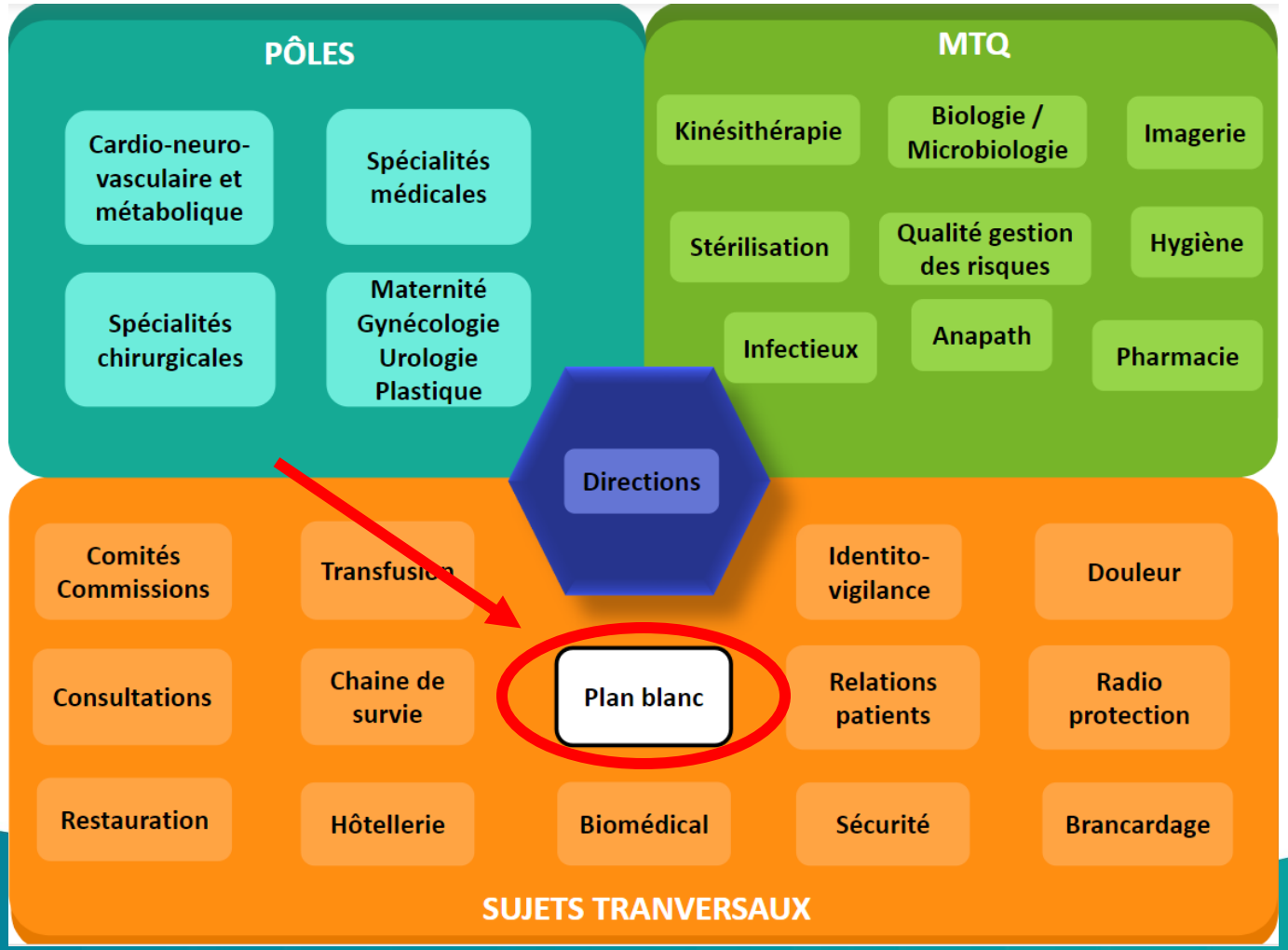
7. Assurer le lien avec les unités d'hospitalisation.

Remarque :
L'annuaire plan blanc disponible sur R/ Accès Paris Saint Joseph / Liaison / annuaire plan blanc recense toutes les coordonnées des professionnels de l'hôpital et est accessible uniquement par l'ADG

Procédure plan blanc

Ensemble

- « Ensemble » - « Procédures et FEI » - «Procédure et protocoles » - « HPSJ »



Film plan blanc



Merci de votre attention

Evaluation de la formation